

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN PEREMPUAN		
	No. Dokumen 429/RSPHS/I-SPO/DIR/VII/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 24 Juli 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Memasukkan selang kateter urin ke dalam kandung kemih melalui uretra pada pasien perempuan		
Tujuan	1. Mengeluarkan urin pada pasien yang mengalami retensi urin atau gangguan eliminasi. 2. Memantau jumlah produksi urin secara akurat. 3. Memperoleh sampel urin untuk pemeriksaan diagnostic. 4. Mengurangi risiko komplikasi akibat retensi urin. 5. Menjaga drainase urin secara kontinu sesuai indikasi medis 6. Menunjang proses diagnosis, terapi, dan pemantauan kondisi pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 935.5/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025 tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien		
Prosedur	A. Persiapan Alat dan Bahan 1. Sarung tangan steril 2. Kateter urin sesuai ukuran 3. Urin bag dan penggantungnya 4. Sput 10 ml 5. WI steril 6. Jelly lidokain 2% 7. Cairan NS untuk membersihkan genetalia 8. Kassa 9. Sarung tangan bersih 10. Wadah sampel urin, jika perlu 11. Underpad / alas 12. Bengkok 13. Sampiran B. Langkah – Langkah 1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap dan tanggal lahir) 2. Jelaskan tujuan dan langkah – langkah prosedur 3. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan 4. Jaga privasi dengan memasang sampiran		

PEMASANGAN KATETER URINE PASIEN PEREMPUAN

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

No. Dokumen
429/RSPHS/I-
SPO/DIR/VII/2026

No. Revisi
01

Halaman
2 / 2

5. Atur posisi dorsal recumbent (kedua lutut dilipat diregangkan/ dibuka)
6. Letakkan pengalas di bawah bokong
7. Tutup area pinggang dengan selimut
8. Lakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah
9. Pasang sarung tangan bersih
10. Bersihkan genetalia dengan kassa dan cairan NS
11. Keringkan, kemudian lepas sarung tangan bersih
12. Buka set kateter steril dan alat – alat steril lainnya dan tempatkan di alas steril dengan tetap mempertahankan Teknik aseptik
13. Pasang sarung tangan steril
14. Sambungkan kateter dengan urin bag
15. Lumasi ujung kateter 2,5 – 5 cm dengan jelly
16. Buka kedua labia minora dengan ibu jari dan telunjuk tangan non dominan
17. Masukkan kateter 5 – 7,5 cm ke dalam meatus uretra secara perlahan sambil menganjurkan tarik nafas dalam.
18. Perhatikan adanya aliran urine dalam selang urin bag
19. Lakukan fiksasi internal dengan memasukkan WI steril untuk mengembangkan balon kateter
20. Tarik kateter perlahan sampai terasa ada tahanan untuk memastikan terfiksasi dengan baik dalam kandung kemih
21. Lepaskan sarung tangan steril
22. Lakukan fiksasi eksternal dengan plester di area paha dalam
23. Gantungkan urine bag dengan posisi lebih rendah dari pasien
24. Pasang sarung tangan bersih dan ambil sampel urine segera dari urine bag, jika perlu
25. Lepaskan sarung tangan bersih
26. Rapihkan pasien dan alat yang sudah digunakan
27. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
28. Dokumentasikan prosedur yang dilakukan (warna urine, jumlah urine yang keluar, jumlah WI steril untuk mengembangkan balon, tanggal/waktu dipasang) dan respon pasien

Unit Terkait

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Instalasi Rawat Jalan (IRJA)
3. Instalasi Rawat Inap (IRNA)
4. *Intensive Care Unit* (ICU)
5. Instalasi Kamar Operasi (IKO)